

Corporéité et États-Limites. Philosophie de la transformation corporelle

Georges Charbonneau

1. États-limites. Caractéristiques générales

Les états-limites ont un statut particulier. Ils restent de l'ordre des troubles de la personnalité dans leurs formes légères et moyennes mais prennent le statut de véritables pathologies (maladies) dans leurs formes sévères. On consacre alors à ces formes majeures le nom anglo-saxon de *borderline*. Le vocable qui les désigne de pathologie située entre névroses et psychoses est devenu, au fil de la détermination et de la fixation du trouble, peu indicatif. Une meilleure connaissance clinique et anthropophénoménologique les situent davantage entre psychopathie, structures addictives et psychoses et voient dans la relation de réalité de ces états-limites une entité autonome par rapport aux psychoses. Ces formes sévères, souvent associées à la schizophrénie et historiquement confondues avec elle dans ce qui fut désigné comme *héboïdophrénie*, réalisent donc une pathologie majeure justifiant le plus souvent un traitement antipsychotique. Dans la lignée des troubles états-limites-borderline, on trouve dans la symptomatologie générale :

1) Une organisation fragile de la personnalité avec des difficultés d'identification et de réidentification particulières, lues ici comme relevant véritablement de la structure d'ipséité. Ces difficultés font évoluer la personne entre indifférences identificatoires, constitution d'un faux-self (« surdifférence »), notamment avec l'appoint d'une élaboration esthétique forcée de son image, et mauvais retour sur soi au décours des expériences de rôles. Rien ne fait histoire. Il n'y a pas de *travail de l'histoire* en lui : tout est absolument identique au décours de tout ce qui peut se produire.

2) Des difficultés d'attachements et d'organisations du lien responsables de ruptures à la fois fréquentes et non constructives.

L'affectation de la structure d'ipséité propre à cette pathologie s'exprime simultanément par un défaut d'investissement des différentes formes d'altérité.

Ces difficultés d'attachement concernent tous les registres du lien : les liens interpersonnels, les liens transgénérationnels (en amont comme en aval, au regard de ses parents comme de ses enfants), les liens aux lieux, aux nostrités, aux époques, etc. Le lien borderline, externe comme interne, est soit fusionnel soit oppositionnel (de l'opposition systématique jusqu'au déni) soit inexistant.

3) La possibilité d'émergences délirantes transitoires, isolées, mal critiquées, qui tendent à s'enkyster ou même à demeurer actives (avec réaménagement et enrichissements ultérieurs). Les délires sont éphémères, constitués, manifestés et enrichis car ils adhèrent peu aux identités de rôle. Le délire peut en effet se comprendre comme une élaboration de rôle démesurée ayant pour finalité de palier aux défaillances de la continuité ipséique. Dans l'expérience état-limite, l'ipséité ne s'appuie pas sur ces médiations identitaires que sont les identités de rôle ; aussi, celles-là, lorsqu'elles sont investies, ne le sont que pauvrement.

4) Une réactivité particulière (hyperréactivité) associée à une pauvreté de la rétention émotionnelle. L'état-limite est hyperréactif : il décide vite, ne s'enlise sur aucune décision, aucun dilemme. Il devance son entourage dans de nombreuses situations. Structurellement, cette configuration état-limite est à l'opposé des phénomènes et procédures identificatoires paranoïaques : à l'inverse de la paranoïa, l'identité humaine ne s'attarde pas sur de longues sédimentations narratives. L'état-limite ne s'attache pas aux nostrités, aux époques. Il manifeste une « sur-historialité », une compétence à s'extraire des sédimentations propres aux âges traversés de l'existence. L'historialité (qui analyse la relation aux âges et aux époques de la vie) de l'état-limite le désencombre de toutes sortes d'inerties identitaires. Il a, contrairement au paranoïaque, une capacité particulière à terminer (annuler, refermer, oublier, dépasser, survoler) les époques pour en recommencer d'autres. Il recommence tout à tout moment. Il n'y a pas de deuil pathologique, par exemple – tout au moins ceux qui peuvent toucher légitimement une relation réelle sont-ils rares – et plus généralement, nous sommes dans une configuration où la dépression, liée à de profondes élaborations antérieures d'identités et à des dépositions de soi dans des relations affectives, dans des liens, des lieux, des rôles divers, est relativement absente, conformément à ce que propose de considérer Gian Paolo Di Piazza (Florence, Italie). Il n'y a pas en effet de sédimentation de soi dans des identités intermédiaires ; rien n'est intimement ou durablement « en jeu » pour l'état-limite, ce qui explique qu'il n'y a pas de risque de perte et donc de dépression.

Cette réactivité particulière extrême se manifeste donc par une absence d'inhibition, de retenu et de scrupules parfois, d'hésitations. Il est alors maître du présent, de l'instant, prenant chacun de vitesse. Il a déjà agi alors que chacun en est encore à se demander s'il était légitime de le faire.

Cette disposition peut avoir dans certains cas des aspects positifs. Dans la création artistique, par exemple, mais aussi face à certaines situations historiques, l'état-limite est capable d'émancipation et de décision fulgurante.

5) Une prédisposition aux addictions et aux comportements extrêmes (comportement à risque, conduites ordaliques, besoin d'événement). Ils constituent un aspect de la réalité addictive. L'état-limite est marqué par une double caractérisation : l'indifférence et la hantise du vide. Il en ressort qu'il s'ennuie. Il est en besoin d'événement, comme dans l'addiction : d'un événement qui à la fois le fait sortir des contraintes antérieures, remobilise son énergie, le relance vers d'autres points d'intérêts, et permet de changer d'identités de rôle. Les comportements extrêmes ont cette fonction de susciter l'événement, de le créer. Cela n'est pas différent de ce qui se produit dans toutes les addictions, organisées par la triade *sentiment d'ennui-besoin d'événement-addiction*. On pourra remarquer que cette structure temporelle addictive est aussi marquée par l'hyperréactivité : ce besoin d'événement (au sens de besoin d'intensité) n'est que l'autre facette du temps d'action addictif. Le temps addictif est un temps accéléré, précipité, qui veut brûler les étapes. C'est dire le rapport structurel qui existe entre addiction et état-limite.

6) Une suicidalité spécifique (F. Landazuri. *Cf intra*). Ce terme désigne un rapport général à la destruction de soi fondé sur une certaine capacité d'annulation-recommencement. Nous en avons vu le caractère historial. La suicidalité va bien au-delà d'un appel au suicide : c'est un mode d'être pour lequel le suicide est intimement possible. Ce suicide est physique mais peut être aussi social et affectif.

Il est possible de caractériser cette relation globale au suicide comme non nécessairement dépressive, liée à un ensemble de trois dispositions :

- un engagement général en tout ou rien (l'état-limite ne transige pas, ne négocie pas, ne partage pas ses affects, ce que son hyperréactivité lui permet.),
- une indifférence à sa propre existence,
- une volonté d'échappement au système, tant celui de l'existence que de celui des rôles ou de la société.

Ce n'est pas un suicide d'échec, de jugement de soi, de chute, de dévalement. Ce n'est pas un suicide d'épuisement non plus encore moins de désespoir. Il peut même survenir au décours d'un succès. C'est en cela que ses caractéristiques échappent à nos catégories qui veulent voir le suicide comme l'aboutissement soit d'un épuisement de l'énergie de vivre, soit de notre pouvoir-être.

C'est un suicide de sortie de jeu. Il réalise une alternative presque ludique avec la vie dans son ensemble.

Le suicide n'est pas nécessairement revendiqué esthétiquement (« culture de la mort ») ou pathétiquement comme dans certaines hystéries sombres (« beau ténébreux ») mais constitue un partenaire intime de vie. Cette suicidalité est floue mais bien réelle : elle est tant active que passive, protéiforme, aléatoire, pouvant aussi bien passer par l'usage de toxique, par des comportements extrêmes que par une décision incompréhensible. En ce dernier cas, ce suicide se réalise sans relation précise avec des événements. C'est spécifiquement en cela que le concept de suicidalité (par le caractère général, dimensionnel, non spécifique, de ce qu'il désigne) est utile. Nous ne sommes pas dans un processus linéaire qui conduirait pas à pas au suicide (cela peut néanmoins se rencontrer) mais dans un climat, un voisinage certes lointain mais bien réel, avec le suicide.

7) Cette indifférence est particulièrement marquée dans les états-limites, alors qu'elle n'est pas présente dans la structure addictive. Il n'y a rien en elle de psychotique. Elle touche à la teneur axiologique, à la valuation fondamentale des constructions symboliques, des relations affectives et autres. L'état-limite voit ce qui peut être vu, est apte à juger de la valeur, mais refuse d'y porter attachement, d'être captif de la moindre habitation. C'est une indifférence secondaire. Elle est de l'ordre de l'habitation des espaces affectifs et des identités sédimentées.

Cette indifférence empêche de jouir et aussi de souffrir. Rien de l'un ni de l'autre n'est apprécié, n'est goûté, n'a de pouvoir de créer du lien ou de s'en défaire. Le jouir comme le souffrir s'oublie aussitôt qu'ils se sont éprouvés. Si cette disposition empêche de faire lien affectif, elle a des aspects adaptatifs : elle permet par exemple aux états-limites d'endurer des échecs, des ruptures ou des incarcérations longues.

Cette indifférence est pré-cynique mais ne favorise pas nécessairement une élaboration perverse de la distance cynique. L'état-limite ne perd pas son temps dans la pensée, les retours en arrière, la jubilation. Tout est aussi vite oublié que mis en projet et réalisé. L'évolution vers le champ complexe de l'*agir pervers* est certes une possibilité de l'état-limite, mais n'est pas la seule. La perversion peut se constituer à partir d'autres organisation de personnalité. Le domaine de cet *agir pervers* demande trop de constance et d'investissement de rôle pour la structure état-limite.

8) Le dégagement de contrainte est le souci premier de l'état-limite. Il ne veut pas être identifié à un rôle stable, une identité, une collectivité marquée par une obligation de réciprocité. S'il y a une trace de nihilisme dans cette attitude, il faut se garder de lui donner un sens moral. Ce n'est pas un nihilisme volontaire. L'état-limite voudrait croire et ressentir, voire même partager mais n'y parvient pas. Il ne rentre pas dans la cohorte des présignifications de sens, celles qui constituent la continuité symbolique de notre vie en commun, il ne s'y est pas attaché. Autrement dit, il ne reçoit pas ce qui est déjà donné, il ne reçoit pas ce qui est implicite, les préjugés et refuse de s'inscrire en tradition. Il veut s'en dégager à tout prix pour ne rien devoir ou redevoir. L'identité de l'état-limite est attirée par celle de

la dés-appartenance, aussi bien à l'égard de lui-même comme soi que comme identité de rôle, ou comme altérité.

L'état-limite peut manifester, forme pure de ce désir de dégagement de contrainte, une « allergie intersubjective » : Il ne supporte pas la proximité. Il se dégage aussitôt qu'il est contraint de s'approcher et de constituer du lien. L'injonction « dégages de ma vie ! » lui est propre. Il tend à faire fuir de son monde tous ceux qui en sont trop proches, ceux qui de fait, tentent de stabiliser ses ancrages.

2. La corporéité des états-limites

La corporéité, plus exactement le processus de notre incarnation en un corps de chair, retrouve les grandes déterminations de notre sens d'existence. S'y exprime notre capacité à investir et habiter le monde, à investir les espaces et temporalités de partage (notamment la nostrité), la matière et sa résistance, à éprouver et donner sens tant à la satisfaction qu'à la douleur ou la souffrance.

Est-elle une expression nouvelle de notre sens d'existence, de notre « inconscient existentiel » ? Ou double-t-elle le phénomène de l'ipséité dans son rapport au sens ? Autrement posé, demandons-nous si il y a une région de notre expérience de corps qui soit autre que celle de notre expérience seule ? Non, sans doute. Dans la voie merleau-pontienne de la corporéité première, ou même dans la corporéité pensante nietzschéenne, il va sans dire que corporéité et ipséité s'instruisent réciproquement ; ils sont pris dans la même aventure du sens.

Toujours est-il que cette corporéité se caractérise par :

1) Défaut d'implications et d'investissements continus dans l'ensemble des conduites corporelles. Que ce soit dans ses enjeux esthétiques, médicaux, dans le déploiement du corps en action, il n'y a aucune gravité corporelle de soi.

-*Idem est*. Pauvreté de l'habitation véritable du corps, et ouverture mimétique de cet investissement aux différentes corporéités sociales (corporéités de *styles de rôles* plutôt que de rôles).

2) Au fond de ce défaut d'implication, on note une pauvreté de l'auto-affectation. Le terme est employé ici en son sens henryen (Michel Henry), à savoir comme expérience de la vie se rencontrant elle-même, mais aussi d'une façon plus générale. L'auto-affectation est l'autre nom ici de l'habitation de soi, de la rencontre interrogative et dévoilante d'un soi-monde que nous ne parvenons jamais à saisir. L'état-limite ne s'éprouve pas lui-même et ne transforme pas son sentiment de présence en un sentiment de monde. Il est toujours en devancement de lui-même, comme par un recouvrement de ce qu'il a été dès l'instant d'avant. Sans constituer pour autant le phénomène maniaque de *l'être en avant de soi*, la temporalité de l'état-limite réalise un décalage de la présence dans une certaine anticipa-

tion de soi, qui n'assume pas véritablement le présent, le brûle plutôt qu'il ne le réalise ou le signifie.

Il n'y a, chez lui, pas ou peu d'énigme de la *Befindlichkeit* heideggérienne, du *se-retrouver-soi-même dans un certain accord de monde*. Cette absence d'ancrage affectif interne à la vie et aussi dans l'instant, lui donne sa réactivité spécifique.

On peut le dire encore autrement : cette incapacité à ressentir des émotions corporelles (de l'ordre d'un *sentiment de monde*, impliquant une *durée*), surtout si elles sont déjà connues, est une restriction pathique et par là-même de la réceptivité simultanée à sa propre expérience comme à celle d'autrui. L'état-limite peut fusionner mais est peu disposé à une empathie véritable. Il fonctionne de ce point de vue, comme pour l'action, en tout ou rien.

4) Ce défaut de l'auto-affectation crée la recherche de sensations extrêmes (toxicomanie, toxicophilie, anorexie, polyphagie, automutilations). Sensations qui ne sont pas « expérimentées » ou « goûtées » pour autant ; aussitôt vécues, rien d'un regard de monde ne leur est attaché. C'est un des lieux les plus significatifs de l'affection de la structure d'ipséité : l'absence d'intégration en retour des éprouvés, quels qu'ils soient.

5) Cette distanciation du rapport au corps (la désacralisation est aussi son nom) et la capacité d'annulation-recommencement autorisent toutes sortes de relations au corps de l'ordre de la *transformation corporelle* (de certains comportements addictifs extrêmes, de la polyphagie ou l'anorexie extrême jusqu'à l'automutilation privative ou constructive, telle l'acceptation de plastie, de prothèse esthétique, jusqu'à la vente d'organe, la GPA, la prostitution, etc... jusqu'à d'autres formes de transformations qu'il faut aborder avec des réserves : aux changements subits de nom ou de prénom, d'identités religieuses, ou de genre (la transsexualité) sur fond d'indifférence. Nous sommes là avec ce terme dans un ordre de troubles qui a un statut ambigu entre normalité et pathologie. Dans certains cas, isolément, elle ne signifie rien, mais dans sa dynamique accélérée, elle s'inscrit dans la pathologie psychologique ou mentale.

Nous pointons ici le fait clinique que l'ordre des transformations corporelles (ou sa constellation) rencontre étonnamment celui de la structure état-limite (ses formes pathologiques). La transformation corporelle accompagne le destin de l'état-limite.

La transformation corporelle n'est pas aisée à définir anthropologiquement, car nous ne vivons pas un corps absolument « naturel » ; il est toujours repris dans un ensemble de significations culturelles qui transforment le corps (de la circoncision aux autres pratiques mutilatrices sexuelles, des pieds cassés chinois aux elongations du cou ou d'autres parties du corps, etc.) selon des significations instituées. Aucune culture ne s'épargne des marques initiatiques, si minimes soient-elles. Pour autant, nous sommes tous en relation avec une image et un sens général du corps, d'un corps dont nous recevons le sens sans le demander. Nous mettons tous des

limites, au moins relatives, à ce qui est le corps humain général. Nous inscrivons les transformations corporelles dans un dialogue esthétique avec le genre humain sans jamais outrepasser le principe de son identité. Il y a une identité de l'homme à lui-même et ce principe n'est pas transgressé. La transformation corporelle est l'esquisse ou l'étape initiale de cette transgression.

Revenons à l'état-limite. Il est dans une double indifférence : de ce qui est à soi et n'est pas à soi, de ce qui est organique et inorganique (dévitalisé, inanimé, matérialisé) ; indifférence aussi à l'idée anthropologique, cet horizon de signification dans lequel nous inscrivons notre parcours de vie. La transformation corporelle commence dès qu'il y a oubli de cet horizon de signification. Il ne s'agit plus d'accomplir le destin humain mais d'accomplir son propre destin sans reprise du projet humain. Une littérature et un imaginaire cinématographique ont préparé cette possibilité destinale extrahumaine.

6) Crise de l'intimité et avec elle incapacité à constituer des horizons progressifs de signification de soi, à séparer le proximal du distal. Tout est donné dans l'extériorité, l'extimité, et donc une prétendue transparence. L'état-limite se vit plus que tout autre dans le champ social : il tente de l'habiter faute de se constituer son propre espace personnel. Comme corrélat de cette perte de l'espace intime, on comprend le rapport à la pudeur très spécifique de l'état limite et avec elle, à la sacralité. L'état-limite voit la pudeur, peut la ressentir, la pratiquer par mimétisme mais elle ne porte pas pour elle un véritable sens d'existence. Il n'en fait pas une expérience privilégiée.

Cette pauvreté du sens de l'intimité (qui procède d'une carence d'élaboration du secret de la vie, qu'on le lise comme tel ou comme secret œdipien, secret protecteur des origines), permet des expériences corporelles inaffectives, comme le body-art, les marques au corps et aussi la prostitution utilitaire.

Les expériences de body-art, les marques au corps, les transformations corporelles, évacuent l'incarnation fondamentale pour lui substituer des messages sociaux de tous ordres. Elles abolissent le mystère premier de la relation à la chair pour rematérialiser le corps.

La prostitution, quant à elle, requiert cette indifférence au soi corporel. Le clivage de l'affect peut se faire d'autant mieux qu'aucun lien ne peut exister aprioriquement. La pudeur ne marque plus le soi du non soi. Rien n'est aliéné de soi dans ce type de relation car l'indifférence du soi à lui-même empêche que le soi s'y expose.

On peut établir un lien entre intimité et sacralité. Nous ne sortirons pas de notre question en effleurant ce point, qui permet d'explorer les liens entre dés-intimisation de son existence et désacralisation.

Ce lien n'est pas tout d'abord un lien d'identité, bien qu'un terme les désigne ensemble tous les deux, celui du tabou. Tabous par exemple de la vie et de sa valeur, tabou de la mort, de la souffrance.

Remarquons bien que le sacré n'est pas l'intime. Le sacré n'est pas même tout simplement *intime*. Le sacré reste extérieur et général, pas nécessairement approprié.

Le second lien est isomorphique : l'intime et le sacré ont en commun de procéder d'une rescision (rescinder) de l'espace général, permettant la constitution d'espace préservé, dont chacun a le souci ; le sacré est une sorte d'intime de l'extériorité ou de l'infini. L'intime et le sacré requièrent une distance de préservation (l'élaboration de cette distance peut se faire par la purification, qui maintient la séparation du pur et de l'impur, à l'instar de l'ipséité et des identités de rôles) ; cette distance est ipséique (c'est une distance du soi à soi) et elle révèle cette réalité que nous ne donnons jamais en entier à nous-mêmes, pas plus qu'autrui ne se révèle à autrui ou à lui-même dans l'entièreté de ce qu'il est.

L'intime et le sacré ne portent pas seulement le sens de soi mais celui d'une appartenance antérieure et extérieure à soi, soit cosmologique, soit biologique : appartenance qui nous précède ou nous succède. Nul n'est, en son existence, que lui-même. Chacun porte un sens qui passe à travers lui, celui d'une sacralité, qu'il est en demeure de préserver et de restituer, aussi bien dans certaines formes extérieures qu'intérieures.

Ce défaut d'investissement de l'état-limite dans l'intimité comme dans la sacralité ne signifie pas que l'intéressé ne puisse le concevoir, ou même l'emprunter ; ils le peuvent mais la carence se situe ailleurs. Ils sont impuissants à les habiter et donc les signifier pour lui durablement, dans un certain sens d'existence.

7) Défaut d'investissement dans la maternité et la paternité. La maternité est un investissement à la fois de l'intimité, de l'être ensemble, de la protection, c'est aussi un don et une expérience de soi transgénérationnelle. Elle est tout le contraire de l'hyperautonomie des états-limites. Elle est acceptation d'une multiplicité de don de soi en vue d'une nouvelle expression de soi. Dons de soi : don esthétique, don en disponibilité et temps concret, renoncements divers (à son autonomie, à sa vie antérieure, à sa liberté affective, etc.). Elle suppose de se concevoir en deçà et au-delà de son seul « entre naître et mourir ».

La maternité n'est alors que partiellement investie. Les précautions nécessaires à cet état (abstinence alcool-tabagique et de toxique, mesures diététiques alimentaires, prise de traitement, horaires de vie, etc.) ne sont pas respectées. L'état de grossesse ne constitue pas une rupture. L'investissement de l'enfant n'est pas inexistant mais peut être inadapté sous de nombreux aspects, aussi bien symboliquement (dans le choix d'un prénom porteur d'un sens de vie), que dans les renoncements qu'il exige. Le monde de l'enfant à venir n'est pas construit, préparé, séparé, positivement.

On retrouvera dans certains cas cette carence dans l'investissement relationnel de l'enfant, quand son éducation et sa vie quotidienne ne sont pas progressivement délégués ou confiées à des tiers. Parfois le rejet

de maternité ou de paternité se manifeste autrement, par des exigences extrêmes ; l'enfant ne peut être aimé qu'avec de nombreuses conditions. Il faut qu'il soit conforme à des schémas idéaux pour être admis.

Cette relation au corps à travers la maternité n'est pas spécifique à l'état-limite ; on peut la retrouver aussi dans les structures marquées par l'anorexie ou la toxicomanie. Il y a certains éléments communs, *a minima*, notamment le rejet transgénérationnel et certaines formes d'allergies intersubjectives.

3. L'état-limite ne tolère pas la proximité affective

Le problème de l'état-limite vis-à-vis de la maternité comme de la paternité, est structurellement plus profond : il renvoie à une certaine incapacité à nouer de la proximité affective, une proximité qui ne soit pas fusionnelle. L'intimité exige un double renoncement :

1) à l'autonomie : l'état-limite est hyperautonome et vit mal qu'on empiète sur un espace propre mal institué ;

2) à l'extériorité et à l'activation qu'elle produit. Il redoute plus que tout autre d'être coupé du système de l'extériorité qui lui permet simultanément de se protéger, de fuir, de se divertir de toute contrainte.

L'intimité est vécue virtuellement d'une façon défensive. Ce sentiment n'est pas exactement persécutoire, au sens paranoïaque du terme, à savoir la méfiance vis à vis d'une intrusion d'un tiers. Il est d'un ordre différent : il veut éviter qu'on prenne la moindre prise sur lui, qu'on restreigne sa capacité à agir, et aussi à se dégager. L'état-limite, lui-même parfois empriseur, ne supporte pas la moindre emprise sur sa personne.

Il est allergique à tous liens réciproques. Cela réalise l'allergie intersubjective. L'absence d'ancrage d'existence qui résulte d'une telle position va faciliter les différents comportements de sa suicidalité ; alors, n'étant plus retenu par aucun lien dynamique, il est moins pesant pour lui de jouer et recommencer le tout pour le tout.

4. Conclusions

L'état-limite est marqué par un ensemble de déterminations plus ou moins stables que nous pouvons résumer ainsi : distanciation par rapport au corps, perte de l'intimité, dés-indentification, hyperautonomie, désaffectation de ses éprouvés, intolérance à sa finitude, besoin de sortir de son histoire humaine, appel à sa transformation, comme pour faire événement dans une existence qui ne s'éprouve pas elle-même. La transformation corporelle est à comprendre dans le spectre de la suicidalité et réciproquement. La corporéité de l'état-limite est celle du corps en signification mais sans sens. C'est un corps qui refuse de recevoir une histoire et de la transmettre.

De ce point de vue, l'état-limite est dans une double relation à son époque : il exprime les transformations récentes de notre conscience cor-

porelle et aussi, leur indique son chemin. Ce qui est perçu comme ses provocations est souvent reçu comme des incitations programmatiques. Il y a en effet une relation culturelle entre le « discours commun au corps » de la société et la corporéité des état-limites. Ce « discours commun du corps » comprend les expressions corporelles fondamentales du corps, tant au plan du corps social, de sa valorisation esthétique générale qu'au niveau des définitions des lieux et modalités de pudeur, que du corps médical ; il définit et redéfinit aussi ce qui est propre et impropre. Une étude plus vaste pourrait inclure la question de l'histoire de l'art (le corps pictural au XX^e siècle a exprimé cette question) dans cette problématique corporelle. L'état-limite ouvre les brèches de cette désacralisation et simultanément exprime les failles de la conscience du corps dans notre société. Sa capacité à prendre place dans le champ social en fait un opérateur de changement important.

Cette relation au corps de l'état-limite n'est pas anthropologiquement anodine. Elle inquiète par la marchandisation du corps et des organes qu'elle encourage. Elle résonne avec le discours général du corps de la modernité ou de l'hypermodernité occidentale, exportée qui plus est dans certains pays où la protection de l'individu n'est pas assurée de la même façon. En cela, l'état-limite, de par l'appel qu'il porte à la transformation corporelle, peut-il être compris comme une pathologie emblématique de la relation occidentale au corps ?